

一般牙齒及阻生齒拔除手術說明書

這份說明書是有關您即將接受的手術（或醫療處置）的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論時的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個手術（或醫療處置）的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

適應症及作法：

（簡述） 以下為拔牙或阻生齒拔除的適應症

1. 嚴重無法治療的牙周病
2. 蛀牙結構破壞太大而無法修補
3. 牙齒外傷斷裂至牙根
4. 外傷導致齒槽骨骨折或牙齒移位
5. 顎骨骨折線上之牙齒
6. 牙齒阻生或發育位置不正而造成後遺症（如本身的牙冠周圍炎、口腔衛生不易維持、造成齒列不正、造成鄰牙蛀牙及牙周病、潛在性囊腫變化，更嚴重者會引起顏面蜂窩性組織炎等。）
7. 乳牙遲未脫落或蛀牙感染而妨礙恆牙正常萌出
8. 因牙周病、牙髓或根尖病變而造成嚴重局部、全身性或遠處器官之感染
9. 為齒列矯正目的，解決齒列空間不足問題。
10. 配合顏面部良性或惡性病變、腫瘤或囊腫切除手術需要
11. 化學治療、骨髓移植、器官移植或頭頸部放射線治療前之預防性拔牙

拔牙是一種手術，必須施打局部麻藥。如果您有下列疾病請事先告知，必要時您的牙醫師會暫緩拔牙手術，並照會相關科別醫師提供意見或診治。

1. 氣喘、呼吸系統疾病
2. 高血壓、心臟、循環系統疾病
3. 糖尿病、甲狀腺功能亢進或低下等內分泌系統疾病
4. 肝臟方面疾病
5. 長期洗腎或服用某些藥物如抗凝血劑、類固醇

6. 血液方面的疾病
7. 曾經或目前罹患癌症
8. 曾接受過骨髓移植、器官移植
9. 過去對某些藥物過敏
10. 正在進行化學療法及放射治療
11. 為 HIV 帶原及其他
12. 目前有精神上的疾病或服用藥物中
13. 過去拔牙手術或施行麻醉時有不良反應產生

效益：(經由手術，您可能獲得以下的效益，但醫師並不能保證您一定能夠獲得其中的任何一項；手術效益與風險性間的取捨，應由您決定。)

- (1)針對不同之拔牙適應症，拔牙可以治療或減少相關疾病的發生
- (2)促進口腔衛生之維持
- (3)手術處置成功率

風險：(沒有任何手術或醫療處置是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是可能仍然有一些醫師無法預期的風險未被列出。) 沒有任何手術是完全沒有風險的，這些風險包括術中、術後可能之暫時或永久性併發症，這些併發症，嚴重時甚至可能威脅生命。以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未被列出。醫師將會為您解釋這些可能產生的風險及處理方式。

(一)一般性併發症

- (1)傷口出血
- (2)傷口疼痛
- (3)傷口腫脹
- (4)拔牙處對應皮膚瘀青
- (5)傷口感染或癒合不良
- (6)局部或全身麻醉風險
- (7)因併發症或手術效果不如預期，必要時需再度手術。

(8)必要時輸血導致之不適感或感染風險(如愛滋病、肝炎等)

(如果您曾接受手術部位放射線治療、正接受或剛接受完化學治療、長期服用免疫抑制劑或抗排斥藥、或患有營養不良、血液方面疾病、糖尿病、尿毒症、肝功能異常、惡性腫瘤或其他引起抵抗病菌能力降低的疾病等，會提高術後傷口感染的機會；如果您正接受或剛接受完化學治療、長期服用抗凝血藥、或患有糖尿病、尿毒症、肝功能不良、引起血液凝固降低的疾病等，會提高出血的機會；如果您年紀超過 60 歲、嚴重貧血、患有心肺方面疾病或功能不佳等，會提高麻醉的風險。)

(二)特殊性併發症

(1)牙根斷裂

(2)乾性齒槽炎

(3)鄰牙牙根暴露引發之酸痛

(4)傷害鄰牙牙周組織

(5)牙齒異位

(6)口鼻竇相通及鼻竇炎

(7)下顎齒槽神經或舌神經傷害，導致暫時或永久性下唇或舌部麻木感

(8)顎骨留下牙根斷片，難以取出或取出時易造成其它後遺症。

(9)造成鄰牙或其補綴物、矯正裝置鬆脫、斷裂、喪失。

(10)鄰近軟組織撕裂傷

(11)開口困難

(12)拔除牙誤吞入食道或氣管

(13)臉部皮膚瘀青

(14)暫時或永久顳顎關節不適感

(15)拔牙後一段時間齒槽骨窩吸收不均，導致尖銳骨片形成，可能需再度手術修整骨頭

(16)下顎骨斷裂

(17)長期之骨內疼痛

(18)顎骨骨髓炎、顎骨壞死、蜂窩性組織炎、壞死性筋膜炎

(19)全身性感染或敗血症

(20)術中大出血

替代方案：如果您決定不施行這個手術或醫療處置，可能會有危險，請與醫師討論您的決定。這個手術或醫療處置的替代方案如下：

1. 不接受治療
2. 比需要拔除較少顆牙齒
3. 以保守性牙齒治療方式取代拔牙
4. 藥物控制
5. 門診持續追蹤

醫師補充說明/病人提出之疑問及解釋:(如無，請填寫無)

術後注意事項：

- (1)拔牙後請咬緊紗布，一小時後自行取出，若繼續出血可再另咬紗布一小時，如再滲血且血色鮮濃，請與醫師聯絡，若僅為口水略帶血色並不代表凝血問題，不必驚慌。
- (2)咬紗布期間，請勿吐口水、說話、吸煙，待麻醉藥劑效用消失後始可進食，食物切忌過熱，勿飲酒、劇烈運動或熱水浴。
- (3)拔牙後第一天可能會有輕微發燒、喉嚨痛等現象。應多休息，減少說話，改食軟或流質食物，拔牙傷口及鄰近牙清潔以漱口取代刷牙法。
- (4)拔牙後 48 至 72 小時，傷口對應之顏面部可能會有明顯腫脹情形，甚至持續數天，此現象多數為正常生理性反應，通常一星期內會逐漸消腫。若有此情形，24 小時內可用冰袋冷敷，每次 20 分鐘，休息 10 分鐘後，再繼續冰敷，24 小時後改熱敷數天，持續至消腫。
- (5)若腫脹持續擴大(持續一星期以上)，無消退跡象，或有持續性發燒、畏寒及出血情形，請速回診檢查。
- (6)若有縫合，一星期後回門診拆線。

醫師已提供一般牙齒及阻生齒拔除手術說明暨同意書供病人參考，且病人對於醫師的說明均充份了解。

一、 擬實施之手術（如醫學名詞不清楚，請加上簡要解釋）

1. 疾病名稱：右側上顎第三大白齒, 左側下顎第三大白齒, 右側下顎第三大白齒, 右側下顎顎骨囊腫
2. 建議手術名稱：右側上顎第三大白齒, 左側下顎第三大白齒, 右側下顎第三大白齒齒切除手術, 右

側下顎顎骨囊腫剷除手術, 合併置放五顆膠原單白

3. 建議手術原因：移除患齒, 移除病灶

二、醫師之聲明

1. 我已經儘量以病人所能瞭解之方式，解釋這項手術之相關資訊，特別是下列事項：

■需實施手術之原因、手術步驟與範圍、手術之風險及成功率、輸血之可能性。

■手術併發症及可能處理方式。

■不實施手術可能之後果及其他可替代之治療方式。

■預期手術後，可能出現之暫時或永久症狀。

2. 我已經給予病人充足時間，詢問下列有關本次手術的問題，並給予答覆：

術後注意事項：

(1)拔牙後請咬緊紗布，一小時後自行取出，若繼續出血可再另咬紗布一小時，如再滲血且血色鮮濃，請與醫師聯絡，若僅為口水略帶血色並不代表凝血問題，不必驚慌。

(2)咬紗布期間，請勿吐口水、說話、吸煙，待麻醉藥劑效用消失後始可進食，食物切忌過熱，勿飲酒、劇烈運動或熱水浴。

(3)拔牙後第一天可能會有輕微發燒、喉嚨痛等現象。應多休息，減少說話，改食軟或流質食物，拔牙傷口及鄰近牙清潔以漱口取代刷牙法。

(4)拔牙後 48 至 72 小時，傷口對應之顏面部可能會有明顯腫脹情形，甚至持續數天，此現象多數為正常生理性反應，通常一星期內會逐漸消腫。若有此情形，24 小時內可用冰袋冷敷，每次 20 分鐘，休息 10 分鐘後，再繼續冰敷，24 小時後改熱敷數天，持續至消腫。

(5)若腫脹持續擴大(持續一星期以上)，無消退跡象，或有持續性發燒、畏寒及出血情形，請速回診檢查。

(6)若有縫合，一星期後回門診拆線。

三、病人之聲明

1. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解施行這個手術的必要性、步驟、風險、成功率之相關資訊。

2. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解選擇其他治療方式之風險。

3. 醫師已向我解釋，並且我已經瞭解手術可能預後情況和不進行手術的風險。

4. 我瞭解這個手術必要時可能會輸血：我 ☒ 同意 ☐ 不同意輸血。

5. 針對我的情況、手術之進行、治療方式等，我能夠向醫師提出問題和疑慮，並已獲得說明。
6. 我瞭解在手術過程中，如果因治療之必要而切除器官或組織，醫院可能會將它們保留一段時間進行檢查報告或供日後研究之用，並且在之後會謹慎依法處理。
7. 我瞭解這個手術有一定的風險，無法保證一定能改善病情。

附註：

一、 手術的一般風險

1. 手術後，肺臟可能會有一小部份塌陷失去功能，以致增加胸腔感染的機率，此時可能需要
2. 抗生素和呼吸治療或其他必要的治療。
3. 除局部麻醉以外之手術，腿部可能產生血管栓塞，並伴隨疼痛和腫脹。凝結之血塊可能會
4. 分散並進入肺臟，造成致命的危險，惟此種情況並不常見。
5. 因心臟承受壓力，可能造成心臟病發作，也可能造成中風。
6. 手術過程仍可能發生難以預期的意外，甚至因而造成死亡。

二、 立同意書人非病人本人者，「與病人之關係欄」應予填載與病人之關係。

三、 手術同意書除下列情形外，應由病人親自簽名：

1. 病人為未成年人或因故無法為同意之表示時，得由法定代理人、配偶、親屬或關係人簽名。
2. 病人之關係人，係指與病人有特別密切關係之人，如伴侶(不分性別)、同居人、摯友等；或依法令或契約關係，對病人負有保護義務之人，如監護人、少年保護官、學校教職員、肇事駕駛人、軍警消防人員等。
3. 病人不識字，得以按指印代替簽名，惟應有二名見證人於指印旁簽名。

四、 醫療機構應於病人簽具手術同意書後三個月內，施行手術，逾期應重新簽具同意書，簽具手術同意書後病情發生變化者，亦同。

五、 手術進行時，如發現建議手術項目或範圍有所變更，當病人之意識於清醒狀態下，仍應予告知，並獲得同意，如病人意識不清醒或無法表達其意思者，則應由病人之法定或指定代理人、配偶、親屬或關係人代為同意。無前揭人員在場時，手術醫師為謀求病人之最大利益，得依其專業判斷為病人決定之，惟不得違反病人明示或可得推知之意思。

六、 醫療機構為病人施行手術後，如有再度為病人施行手術之必要者，仍應重新簽具同意書。

七、 醫療機構查核同意書簽具完整後，一份由醫療機構連同病歷保存，一份交由病友收執。

八、 見證人部分，如無見證人得免填載。